PROTOCOLE DE RECHERCHE · DOCTORAT EN SANTÉ PUBLIQUE (PH. D.)

Organiser la réponse intersectorielle aux besoins sociaux complexes et co-occurrents en soins primaires

Configuration des réseaux adaptés aux différents profils de patients pris en charge



Eric Bernier, LL.M. et M. Sc.
eric.bernier.1@umontreal.ca
Doctorat en santé publique · Systèmes, organisations et politiques de santé · ESPUM, Université de Montréal

SOUS LA CO-DIRECTION DES
Dres Nadia Sourial et Géraldine Layani

01 Contexte

En soins primaires, les besoins sociaux se cumulent

54 %
des patients ont au moins un besoin social non comblé
Jih et al., 2023

351
combinaisons différentes d'au moins deux besoins
Kreuter et al., 2021

TROIS NOTIONS À DISTINGUER

La co-occurrence se compte ; la complexité se décrit ; la réponse intersectorielle s'organise sur un territoire.

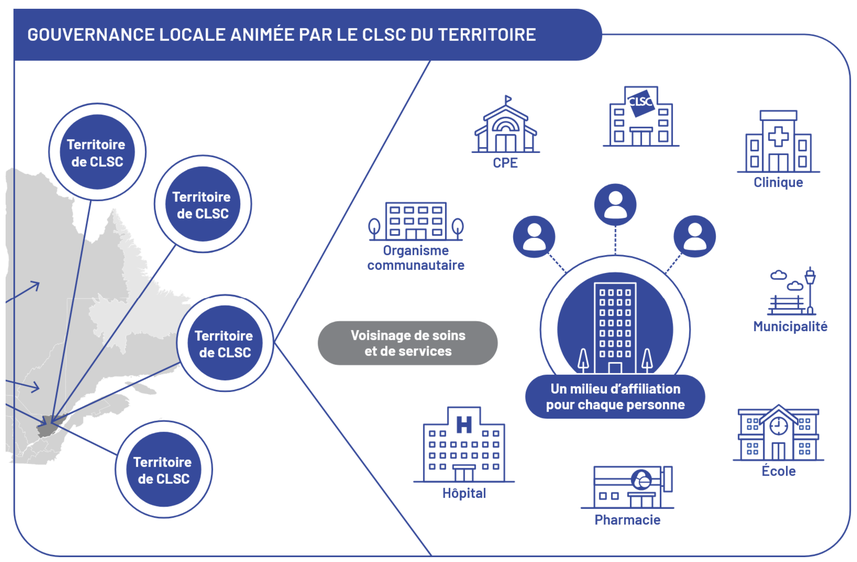
CRITÈRE D'INCLUSION
Co-occurrence
Au moins deux besoins sociaux présents en même temps.
Kreuter et al., 2021

DÉCRITE, PAS EXIGÉE
Complexité
Cumul de maladies chroniques, d'incapacités, de problèmes de santé mentale et de vulnérabilité sociale.
Kuluski et al., 2017

S'ORGANISE SUR UN TERRITOIRE
Réponse intersectorielle
Actions d'autres secteurs que la santé, menées avec elle, sur la santé ou ses déterminants : CLSC, hôpital, GMF, pharmacies, organismes communautaires, municipalité, écoles, CPE, privé.
MSSS, 2017 ; Leppo et al., 2013

POLITIQUE DE PREMIÈRE LIGNE · MSSS, 2026

Le territoire de CLSC devient l'unité de référence



QUATRE RÔLES DU CLSC

Navigateur | Coordonnateur | Leader intersectoriel | Coanimateur

« dans un esprit de gouvernance partagée » · MSSS, 2026, p. 42 · schéma : MSSS, 2026

EXEMPLE FICTIF · FIL ROUGE

MP **Mme Protocole** · 58 ans
Qui répond ? Avec qui ? Qui coordonne ?

Avis d'expulsion → Insécurité alimentaire → Dettes → Dépression (contexte clinique)

LA LACUNE

Le CLSC doit coordonner. Mais pour une combinaison de besoins, rien ne dit quels partenaires mobiliser, comment les relier ni qui coordonne.

QUESTION DE RECHERCHE

Comment s'organise la réponse intersectorielle aux différents profils de patients ayant des besoins sociaux complexes et co-occurrents pris en charge en soins primaires ?

But : relier chaque profil à… un profil de besoins → une configuration de partenaires → et son coordonnateur

02 Méthodes

Terrain : un territoire de CLSC en Lanaudière · devis en plusieurs phases · O2 : réseau égocentré du CLSC, mixte séquentiel explicatif

Quels profils ?

O1 · IDENTIFIER
Revue de portée

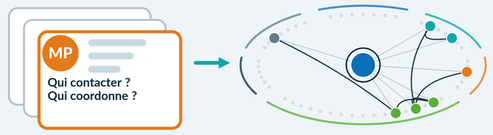
Études publiées
Profils récurrents
Vignettes

→ 4 à 6 vignettes validées

MP *Son profil est repéré dans les études*

Qui mobiliser ?

O2 · ANALYSER
Réseau égocentré du CLSC



→ une configuration par profil

MP *Elle devient une vignette*

Pourquoi ces choix ?

O2 · ANALYSER
Entretiens avec la carte



→ des explications par profil

MP *Sa carte sert de support d'entretien*

Que recommander ?

O3 · RECOMMANDER
Atelier délibératif



- Patients partenaires
- Soins primaires
- Communautaire
- Gouvernance locale
- Municipal, privé

→ des recommandations par profil

MP *Son dossier est délibéré en atelier*

Intégrer

2026 → 2029
Tableau conjoint par profil

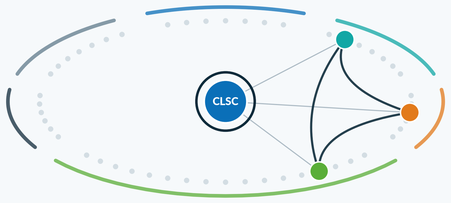
Profil	Réseau	Pourquoi	Reco.
A			
B			
C			

MP *Des repères pour son profil*

03 Résultats anticipés

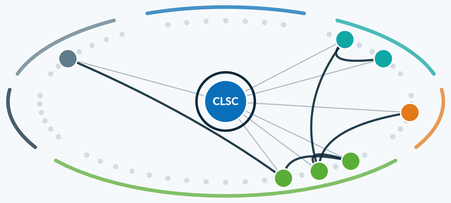
Exemples fictifs · **le réseau égocentré du CLSC change selon le profil**

A **Dominante logement**
avis d'expulsion



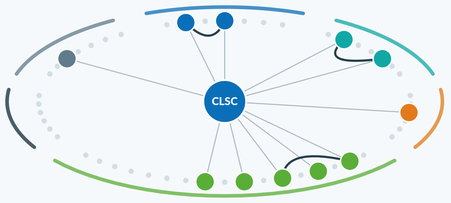
3 partenaires, tous reliés · le CLSC coordonne

B **Mme Protocole**
logement · alimentation · dettes



7 partenaires, encore reliés · le CLSC coordonne

C **Cumul + dépression**
mêmes besoins, plus une dépression



11 partenaires, peu reliés · sans coordonnateur

CLSC (ego) · coordonnateur désigné · lien entre partenaires · organisation non mobilisée
Santé et services sociaux · Première ligne, pharmacies · Communautaire · Municipal · Éducation, petite enfance · Emploi, justice, privé

H1 Les secteurs changent selon le profil
H2 Un noyau commun, une périphérie propre
H3 Plus de partenaires, mais moins reliés
H4 Le CLSC navigue et coordonne ?
H5 Le genre change-t-il la réponse ?

04 Impacts et retombées

Pas un « réseau idéal » universel : des repères pour chaque profil.

Pour les personnes
Une réponse ajustée à leur combinaison de besoins

Pour le CLSC et ses partenaires
Des repères : qui mobiliser, comment se relier, qui coordonne

Pour la politique de première ligne
Un état de départ ; des recommandations selon les quatre rôles du CLSC

Pour la recherche
Une hypothèse profil–réseau ; un réseau égocentré par profil, obtenu par vignettes

Version anglaise, daltonienne et audio
English · colour-blind · audio

Commentez, suggérez, contactez-moi
Lectures · mises en contact · idées de méthode

Références : Creswell et Plano Clark, 2017 · Gale et al., 2013 · Jih et al., 2023, BMC Primary Care · Kreuter et al., 2021, Population Health Management · Kuluski et al., 2017, Int J Integr Care · Leppo et al., 2013 · Leutz, 1999 · MSSS, 2017 ; 2026, politique sur les soins et services de première ligne · Peters et al., 2020 · Thorne, 2016